



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN KINERJA KOMITE KEPERAWATAN
TRIMESTER IV
RS PRIMA HUSADA SUKOREJO
TAHUN 2025**

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan

Telp. 0343 - 6745000

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

LAPORAN KINERJA KOMITE KEPERAWATAN TRIMESTER IV TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan keperawatan merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan di rumah sakit yang berperan penting dalam upaya peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Perawat sebagai tenaga profesional memiliki tanggung jawab dalam memberikan asuhan keperawatan yang aman, efektif, berorientasi pada kebutuhan pasien, serta sesuai dengan standar profesi dan kode etik keperawatan.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola klinis (clinical governance) yang baik, rumah sakit wajib membentuk Komite Keperawatan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit. Komite Keperawatan memiliki fungsi utama untuk meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui pelaksanaan kredensial, pemeliharaan mutu profesi, serta pembinaan etika dan disiplin profesi tenaga keperawatan.

Selain memenuhi ketentuan regulasi, keberadaan Komite Keperawatan juga mendukung pemenuhan standar akreditasi rumah sakit, khususnya dalam upaya peningkatan mutu pelayanan, keselamatan pasien, pengembangan kompetensi staf, serta penerapan tata kelola klinis yang efektif dan berkesinambungan. Komite Keperawatan berperan dalam memastikan bahwa setiap tenaga keperawatan memiliki kewenangan klinis yang sesuai dengan kompetensinya, memperoleh pengembangan profesional berkelanjutan, serta menjalankan praktik keperawatan sesuai standar profesi dan ketentuan yang berlaku.

Selama periode Trimester IV, Komite Keperawatan telah melaksanakan berbagai program kerja yang meliputi kegiatan kredensial dan rekredensial tenaga keperawatan, audit keperawatan, pembinaan etik dan disiplin profesi, pengembangan profesional berkelanjutan (Continuing Professional Development/CPD), serta monitoring dan evaluasi mutu pelayanan keperawatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan mutu pelayanan keperawatan dan mendukung pencapaian indikator mutu rumah sakit.

Laporan Kinerja Komite Keperawatan Trimester IV ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja, sarana evaluasi terhadap capaian kegiatan yang telah dilaksanakan, identifikasi hambatan dan peluang perbaikan, serta sebagai dasar penyusunan rencana tindak lanjut pada periode berikutnya. Dengan adanya laporan ini diharapkan kinerja Komite Keperawatan dapat terus ditingkatkan guna mendukung tercapainya pelayanan keperawatan yang profesional, bermutu, berfokus pada keselamatan pasien, serta sesuai dengan standar akreditasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2017 tentang Jenjang Karir Profesional Perawat Klinis.



4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/425/2020 tentang Standar Profesi Perawat.
6. Kepdirjen Nomor HK.02.02.D.47104.2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit.
7. Kepdirjen Nomor 43961.2024 tentang Revisi 02 Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit 7 Agustus 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Laporan Kinerja Komite Keperawatan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Keperawatan dalam menjaga profesionalisme, kompetensi, mutu praktik klinis, serta penegakan etik dan disiplin tenaga keperawatan di rumah sakit.

Laporan ini juga dimaksudkan sebagai dokumen monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kredensial, rekredensial, penetapan kewenangan klinis, pembinaan mutu profesi, serta penanganan pelanggaran etik dan disiplin sesuai standar akreditasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tujuan Umum

Mewujudkan tata kelola keperawatan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada keselamatan pasien melalui penguatan kompetensi staf, peningkatan mutu asuhan keperawatan, serta penegakan etik dan disiplin profesi secara berkelanjutan.

3. Tujuan Khusus

- a. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kredensial dan rekredensial tenaga keperawatan sesuai standar kompetensi dan kewenangan klinis.
- b. Memastikan kesesuaian antara kompetensi individu dengan kewenangan klinis (clinical privilege) yang diberikan oleh Direktur Rumah Sakit.
- c. Mengidentifikasi capaian indikator mutu asuhan keperawatan dan tingkat kepatuhan terhadap standar praktik profesional.
- d. Mengevaluasi kepatuhan tenaga keperawatan terhadap kode etik profesi dan peraturan internal rumah sakit.
- e. Mengidentifikasi dan menganalisis kasus pelanggaran etik dan disiplin serta memastikan tindak lanjut yang objektif, transparan, dan edukatif.
- f. Memberikan rekomendasi perbaikan kepada Direktur Rumah Sakit dalam rangka peningkatan mutu pelayanan keperawatan dan keselamatan pasien.
- g. Menjadi dasar perencanaan program peningkatan kompetensi dan pengembangan profesional berkelanjutan (Continuing Professional Development/CPD).



BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Visi

“Menjadi Rumah Sakit berkualitas prima pilihan seluruh lapisan masyarakat”

2.2 Misi

1. Memberikan pelayanan kesehatan dengan aman, tepat, cepat dan akurat.
2. Mengutamakan kepuasan dan keselamatan pasien.
3. Meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan.

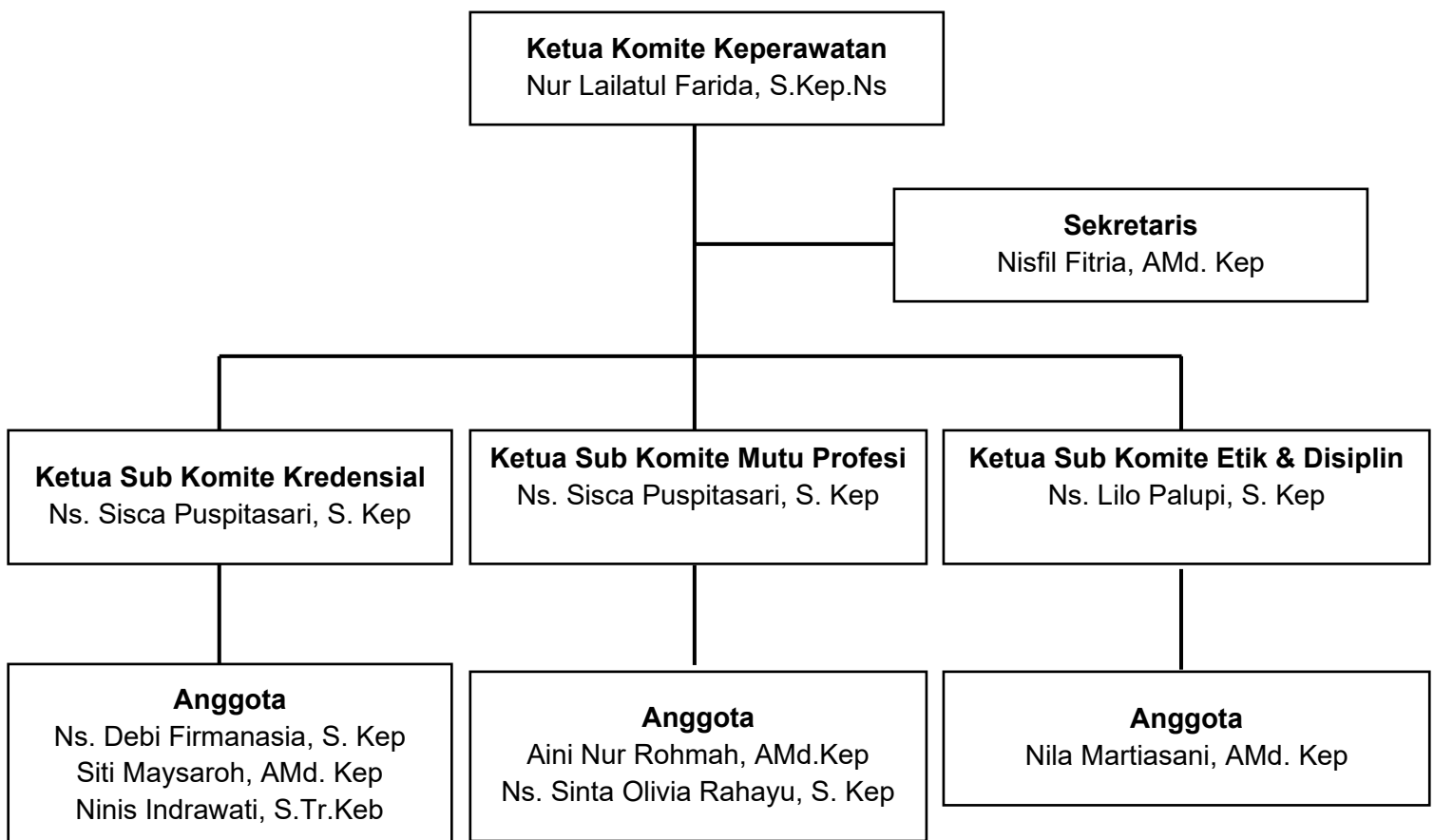
2.3 Motto

“Sahabat menuju sehat”

2.4 (7) Nilai Budi Utama

1. Jujur dipercaya
2. Tanggung jawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adil
7. Peduli

2.5 SOTK



Bagan 2.5.1 SOTK Komite Keperawatan



BAB III

KEGIATAN YANG DILAKUKAN DAN HASIL YANG DICAPAI

3.1 Sub Komite Kredensial

3.1.1 Kegiatan yang Dilakukan

1. Kredensial tenaga perawat baru
2. Rekredensial tenaga keperawatan
3. Verifikasi STR dan SIP
4. Penetapan Kewenangan Klinis

3.1.2 Hasil Kegiatan

Tabel 3.1.2.1 Hasil Kegiatan Sub Komite Kredensial

No	Kegiatan	Target	Realisasi	Keterangan
1	Kredensial perawat baru	100%	100%	Dilaksanakan sesuai jadwal
2	Rekredensial tenaga perawat	100%	85%	Sebagian dokumen belum lengkap
3	Verifikasi STR/SIP	100%	100%	Seluruh dokumen aktif
4	Penetapan kewenangan klinis	100%	100%	Sudah diperbaharui

Tabel 3.1.2.2 Permasalahan dan Tindak Lanjut

No	Permasalahan	Tindak Lanjut
1	Masih terdapat tenaga keperawatan yang belum mengajukan rekredensial sesuai jadwal yang ditentukan	Membuat sistem pengingat masa berlaku kewenangan klinis dan menyampaikan notifikasi kepada kepala ruangan
2	Ditemukan sertifikat kompetensi yang telah habis masa berlaku namun belum diperbarui	Melakukan pemetaan kebutuhan pelatihan dan menyusun jadwal pelatihan prioritas sesuai kompetensi yang dibutuhkan
3	Belum seluruh logbook kewenangan klinis terisi secara lengkap	Melakukan monitoring berkala oleh kepala ruangan dan evaluasi pengisian logbook setiap bulan

Tabel 3.1.2.3 Jumlah Tenaga Keperawatan Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jenis PK				Total
		Pra PK	PK 1	PK 2	PK 3	
Perawat						
1	D3 Keperawatan	-	34	60	2	96
2	D4 Keperawatan	1	-	1	-	2
3	Ners	18	34	39	8	99
Total		19	68	100	10	197
Bidan						
1	D3 Kebidanan	-	3	5	-	8
2	D4 Kebidanan	3	1	9	-	13
3	S1 Kebidanan	-	1	1	-	2
Total		3	5	15	0	23

Tabel 3.1.2.4 Jumlah Tenaga Keperawatan Berdasarkan Jenjang Klinis Setiap Unit

No	Unit	Pendidikan	Jenis PK			
			Pra PK	PK 1	PK 2	PK 3
1	Hemodialisa	D3 Keperawatan	-	-	2	-



		Ners	-	1	2	-
2	ICU	D3 Keperawatan	-	1	5	-
		Ners	-	-	6	-
3	IGD	D3 Keperawatan	-	3	5	-
		Ners	2	7	8	-
		D3 Kebidanan	-	2	1	-
		D4 Kebidanan	-	-	1	-
4	IKO	D3 Keperawatan	-	1	7	2
		Ners	-	-	1	2
5	IRJA	D3 Keperawatan	-	3	11	-
		Ners	2	3	2	1
		D3 Keperawatan Gigi	1	-	-	-
		D3 Kebidanan	-	-	1	-
		D4 Kebidanan	-	-	1	-
		S1 Kebidanan	-	-	1	-
6	IRNA 2A	D3 Keperawatan	-	9	4	-
		Ners	-	9	2	-
7	IRNA 2B	D3 Keperawatan	-	3	3	-
		Ners	6	4	8	1
8	IRNA 3A	D3 Keperawatan	-	2	6	-
		D4 Keperawatan	1	-	1	-
		Ners	-	2	36	-
9	IRNA 3B	D3 Keperawatan	-	4	7	-
		Ners	2	6	2	-
10	Maternitas	D3 Kebidanan	-	1	2	-
		D4 Kebidanan	3	1	6	-
		S1 Kebidanan	-	1	-	-
11	Neonatologi	D3 Keperawatan	-	2	4	-
		Ners	-	-	3	1
12	Manajemen	D3 Keperawatan	-	-	3	-
		Ners	-	-	1	3
		D3 Kebidanan	-	-	1	-
		D4 Kebidanan	-	-	1	-
13	Perawat Klinik	D3 Keperawatan	-	5	1	-
		Ners	-	1	-	-
Total			17	71	145	10
Total Keseluruhan			243			

Tabel 3.1.2.5 Pelaksanaan Kredensial di Trimester 4 Tahun 2025

No	Bulan	Unit	Kategori PK			
			Pra PK	PK 1	PK 2	PK 3
1	Oktober	ICU	-	-	1	-
		IGD	-	-	3	-
		IKO	-	-	1	-
		IRJA	-	-	2	-
		IRNA 2A	-	-	2	-
		IRNA 2B	-	-	5	-
		IRNA 3A	-	-	3	-
		IRNA 3B	-	-	3	-
		NICU	-	-	1	-
		PPI	-	-	1	-
2	November	IRJA	-	1	-	-



		Klinik	-	3	-	-
3	Desember	IRJA	1	-	-	-

Tabel 3.1.2.6 Rincian Peserta Kredensial

No	Bulan	Unit	Nama Staf	Kategori PK
1	Desember	IRJA	1. Mega Cynthia Rahmawati, S.Kep.,Ns	Pra PK
2	November	IRJA	1. Mariatul Qiftiyah, S.Tr.Kep	PK 1
		Klinik	2. Dia Ayu Wulandari, AMd.Kep 3. Muhammad Rifki Andika, AMd.Kep 4. Eka Kurnia Oktaviani, Amd.Kep	
3	Oktober	ICU	1. Roikhatul Jannah, S.Kep.,Ns	PK 2
		IGD	2. Muhammad Abil, Amd.Kep 3. Muhammad Sartono, AMd.Kep 4. Sri Rahayu Kurniawati, S.Kep.,Ns	
		IKO	5. Moch. Agung Setiawan, Amd.Kep	
		IRJA	6. Selvia Leli Agus Nika, S.Kep.,Ns 7. Novi Lianita Indra, S.Keb.,Bd	
		IRNA 2A	8. Devi Apriliyanti, Amd.Kep 9. Mutiatul Khoiroh, Amd.Kep	
		IRNA 2B	10. Durriyatin Nabila, Amd.Kep 11. Vella Octavianita, Amd.Kep 12. Husnita Faradiba, S.Kep.,Ns 13. Izzaty Amalia Rasyadi, S.Kep.,Ns 14. Moh Ivanus Sholihin, S.Kep.,Ns	
		IRNA 3A	15. Eriq Harmoko, Amd.Kep 16. Zaifatus Saila, Amd.Kep 17. Mery Ayu Maharani, Amd.Kep	
		IRNA 3B	18. Mochammad rafi' Dwi Handoko, Amd.Kep 19. Nafa Wahyuning Tyas, Amd.Kep 20. Zairina Rahmawati, Amd.Kep	
		PPI	21. Dwi Sika Hardiyanti, S.Kep.,Ns	
		NICU	22. Lailatul Izmalia, Amd.Kep	

3.2 Sub Komite Mutu profesi

3.2.1 Kegiatan yang Dilakukan

1. Audit dokumentasi asuhan keperawatan
2. Pendampingan clinical instructor
3. Pelatihan internal keperawatan
4. Monitoring indikator mutu keperawatan

3.2.2 Hasil Kegiatan

Tabel 3.2.2.1 Hasil Kegiatan Sub Komite Mutu Profesi

No	Kegiatan	Target	Realisasi	Keterangan
1	Audit dokumentasi asuhan keperawatan	3 kali	3 kali	Nilai kepatuhan 88%
2	Pendampingan clinical instructor	100%	100%	Berjalan baik



3	Pelatihan internal keperawatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Berjalan baik
4	Monitoring indikator mutu keperawatan	100%	100%	Dilaporkan rutin

Tabel 3.2.2.2 Hasil Evaluasi dan Rencana Perbaikan

No	Hasil Evaluasi	Rencana Perbaikan
1	Kepatuhan dokumentasi asuhan keperawatan belum mencapai target 100%	Melaksanakan refreshment dokumentasi keperawatan dan supervisi berkala pada unit dengan tingkat kepatuhan rendah
2	Hasil audit keperawatan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pengkajian, diagnosis, intervensi, dan evaluasi keperawatan	Melakukan audit terfokus dan pendampingan oleh kepala ruangan serta perawat penanggung jawab mutu
3	Hasil supervisi praktik profesional masih menemukan variasi penerapan standar asuhan keperawatan antar unit	Melakukan sosialisasi ulang SPO dan standar asuhan keperawatan serta supervisi lintas unit
4	Beberapa indikator mutu keperawatan belum mencapai target yang ditetapkan	Melakukan evaluasi indikator mutu setiap bulan dan menyusun rencana perbaikan berbasis data

Tabel 3.2.2.3 Diklat Keperawatan

No	Nama Diklat	Waktu Pelaksanaan	Sasaran
1	Sasaran Keselamatan Pasien (SKP)	22 – 24 Oktober 2025	Perawat dan Bidan
2	Hak Pasien dan Keluarga (HPK)	29 November 2025	Perawat dan Bidan
3	Penyiapan Obat Intravena dan Teknik Aseptik	5 Desember 2025	Perawat dan Bidan
4	Safety Medication	18 Desember 2025	Perawat dan Bidan

3.3 Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi

3.3.1 Kegiatan yang Dilakukan

1. Sosialisasi kode etik keperawatan
2. Pembinaan disiplin profesi
3. Penanganan laporan pelanggaran etik atau disiplin

3.3.2 Hasil Kegiatan

Tabel 3.3.2.2 Hasil Kegiatan Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi

No	Kegiatan	Target	Realisasi	Keterangan
1	Sosialisasi kode etik	1 kegiatan	1 kegiatan	Diikuti seluruh kepala ruang
2	Pembinaan disiplin	100%	100%	Dilaksanakan berkala
3	Penanganan laporan etik	100%	100%	Tidak ada kasus berat

Tabel 3.3.2.2 Temuan dan Tindak Lanjut

No	Hasil Evaluasi	Rencana Perbaikan
1	Beberapa kasus terkait ketidakpatuhan terhadap SPO	Pembinaan langsung kepada perawat terkait



2	Perlu peningkatan pemahaman etika komunikasi dengan pasien	Edukasi ulang kode etik dan disiplin profesi
---	--	--

BAB IV MONITORING EVALUASI

4.1 Monitoring

Tabel 4.1.1 Hasil Monitoring

No	Kegiatan	Jumlah yang dipantau/ diobservasi/ sampel	Hasil Temuan	Akar Masalah	RTL	PIC	Ket
1	Audit kelengkapan dokumen kredensial	10 file kredensial	4 file belum lengkap (sertifikat pelatihan dan logbook kompetensi)	Kelalaian dalam pengumpulan dokumen	Melengkapi dokumen dan melakukan monitoring bulanan	Subkomite Kredensial	Belum selesai 100%
2	Audit dokumentasi asuhan keperawatan	20 rekam medis	9 rekam medis belum lengkap pada bagian evaluasi keperawatan	Kurangnya ketelitian	Supervisi dan refreshment dokumentasi keperawatan	Subkomite Mutu Profesi	Perlu monitoring ulang
3	Supervisi penerapan SPO keperawatan	10 unit pelayanan	Kepatuhan rata-rata 92%, ditemukan variasi penerapan SPO di 2 unit	Sosialisasi SPO belum merata	Sosialisasi ulang dan supervisi terjadwal	Subkomite Mutu Profesi	Sedang diperbaiki
4	Monitoring indikator mutu keperawatan	6 indikator mutu	1 indikator belum mencapai target yaitu kelengkapan dokumentasi keperawatan	Kepatuhan pengisian masih rendah	Analisis PDSA dan monitoring bulanan	Subkomite Mutu Profesi	Menjadi prioritas perbaikan
5	Monitoring kedisiplinan kehadiran staf	85 tenaga keperawatan	24 staf terlambat lebih dari 3 kali dalam satu bulan	Disiplin individu belum optimal	Pembinaan dan monitoring kehadiran	Kepala Ruangan dan Subkomite Etik	Evaluasi

4.2 Evaluasi

1. Berdasarkan hasil monitoring Triwulan IV, sebagian besar kegiatan Komite Keperawatan telah berjalan sesuai dengan program kerja yang ditetapkan. Temuan yang masih memerlukan perhatian meliputi kelengkapan dokumentasi asuhan keperawatan, kepatuhan terhadap standar komunikasi SBAR, kelengkapan dokumen kredensial, dan pelaksanaan Evidence Based Nursing (EBN). Secara umum terjadi peningkatan kepatuhan dibandingkan triwulan sebelumnya, terutama pada aspek disiplin profesi dan implementasi standar pelayanan keperawatan.
2. Hasil monitoring ini akan menjadi dasar penyusunan program kerja dan rencana perbaikan berkelanjutan pada tahun berikutnya untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan keperawatan, profesionalisme tenaga keperawatan, serta keselamatan pasien.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kerja Komite Keperawatan pada Triwulan IV, seluruh kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik dan sebagian besar target kinerja berhasil dicapai. Pelaksanaan kegiatan pada Subkomite Kredensial, Subkomite Mutu Profesi, serta Subkomite Etik dan Disiplin Profesi telah memberikan kontribusi dalam menjaga profesionalisme tenaga keperawatan, meningkatkan mutu pelayanan, dan mendukung keselamatan pasien di rumah sakit.

Subkomite Kredensial telah melaksanakan proses kredensial dan rekredensial tenaga keperawatan sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagian besar tenaga keperawatan telah memiliki kewenangan klinis yang sesuai dengan kompetensi dan area praktiknya. Monitoring terhadap masa berlaku STR, SIP, dan sertifikat kompetensi juga telah dilaksanakan secara berkala.

Subkomite Mutu Profesi telah melaksanakan audit keperawatan, supervisi praktik profesional, kegiatan pengembangan kompetensi, serta evaluasi indikator mutu pelayanan keperawatan. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan terhadap standar pelayanan dan dokumentasi asuhan keperawatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Namun masih ditemukan beberapa area yang memerlukan perbaikan, terutama dalam konsistensi pendokumentasian dan pemenuhan kompetensi berkelanjutan.

Subkomite Etik dan Disiplin Profesi telah melakukan pembinaan, sosialisasi kode etik, monitoring disiplin, serta tindak lanjut terhadap pelanggaran yang ditemukan. Secara umum kepatuhan tenaga keperawatan terhadap kode etik, disiplin kerja, dan budaya keselamatan pasien menunjukkan tren yang baik dengan penurunan jumlah pelanggaran dibandingkan periode sebelumnya.

Secara keseluruhan, kinerja Komite Keperawatan selama Triwulan IV dan sepanjang tahun berjalan telah mendukung tercapainya pelayanan keperawatan yang profesional, bermutu, aman, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam penyusunan program kerja dan strategi peningkatan mutu pelayanan keperawatan pada tahun berikutnya.

5.2 Rekomendasi

1. Melanjutkan program monitoring dan evaluasi kredensial secara berkala untuk memastikan seluruh tenaga keperawatan memiliki kewenangan klinis yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan pelayanan rumah sakit.
2. Menyusun dan melaksanakan program pengembangan kompetensi berkelanjutan berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan pelatihan, hasil audit, serta perkembangan pelayanan kesehatan.
3. Meningkatkan kualitas dokumentasi asuhan keperawatan melalui supervisi rutin, audit berkala, dan pendampingan kepada unit yang masih memiliki tingkat kepatuhan rendah.
4. Mengoptimalkan kegiatan mentoring dan preceptorship bagi perawat baru maupun perawat yang mendapatkan kewenangan klinis tambahan.
5. Memperkuat implementasi budaya keselamatan pasien melalui peningkatan kepatuhan terhadap sasaran keselamatan pasien, komunikasi efektif, dan pelaporan insiden keselamatan pasien.



6. Meningkatkan peran kepala ruangan dalam melakukan pembinaan disiplin, evaluasi kinerja, serta pengawasan terhadap penerapan standar praktik keperawatan.
7. Menindaklanjuti seluruh temuan hasil audit, supervisi, dan monitoring dengan rencana perbaikan yang terukur serta melakukan evaluasi efektivitas tindak lanjut secara berkala.
8. Mengembangkan sistem monitoring berbasis indikator mutu keperawatan yang lebih efektif sebagai dasar pengambilan keputusan dan perencanaan program kerja tahun berikutnya.
9. Mempertahankan capaian yang telah memenuhi target serta melakukan perbaikan berkelanjutan pada area yang masih memerlukan peningkatan agar mutu pelayanan keperawatan semakin optimal.
10. Menyusun program kerja Komite Keperawatan tahun berikutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja, kebutuhan organisasi, standar akreditasi rumah sakit, serta regulasi yang berlaku.

Mengetahui,
Direktur RS Prima Husada



Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep.,M.Kep

Pasuruan, 30 Desember 2025
Ketua Komite Keperawatan

Ns. Nur Lailatul Farida, S.Kep